

Vérification des annotations — q6

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 26 juillet 2026

q6 — 6. Quels types de situations problématiques votre organisme rencontre-t-il le plus fréquemment en lien avec le respect des droits des usagers ?

Propriété annotée : *Quel est le type principal de problème signalé par la réponse (barrière d'accès, information/communication, confidentialité/consentement, refus/stigmatisation/soins inadaptés, délais/suivi, ou absence de problème) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 112 réponses (90 internet, 22 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accès aux services	26	23.2%	25	1
Refus, stigmatisation ou soins inadaptés	25	22.3%	19	6
Manque d'information/communication	18	16.1%	12	6
Délais et suivi insuffisants	17	15.2%	10	7
Aucun problème rencontré	11	9.8%	11	0
Confidentialité et consentement	8	7.1%	7	1
non classable	7	6.2%	6	1
Total	112		90	22

Accès aux services (n=26)

#2 • internet

avoir peur d'être hospitalisé de force en santé mentale

accès aux programmes

#7 • internet

les services disponibles

#9 • internet

Accès à des services

#13 • internet

L'accès aux soins de santé puisqu'elles ne cadrent pas dans aucun service de première ligne tel que les cliniques itinérantes qui permettent aux gens sans domicile fixe d'obtenir des soins

#15 • internet

L'incapacité des personnes à accéder aux ressources de santé : environnement hostile (i.e. gardes de sécurité, personne d'accueil qui doivent contraindre une personne à une grille d'analyse plutôt qu'à son entièreté), bâtiments inaccessibles (loin des transports en commun, manque de rampe d'accès ou d'ascenseur), refus de services (stigmatisation, manque de papiers, usagers à qui on doit parler de manière vulgarisée et simple).

#19 • internet

Impossibilité de relocaliser nos clientes à cause de leur precarité financière et de leur antécédant judiciaire

#21 • internet

l'inaccessibilité aux services quand ils existent, ou tout simplement les services ne sont pas disponibles pour personnes TSA.

De plus, la lourdeur des démarches administratives en place aux CIUSSS

#26 • internet

Pas d'accès aux services, logue liste d'attente, pas de services adaptés aux besoins, résultats différents de la consultation si la personne est accompagnée ou non.

#32 • internet

L'Accessibilité aux services

Volontariat

Ouverture d'esprit et le non jugement de la part des professionnels.

#36 • internet

L'accès aux soins est compliqué pour les personnes qui ne sont pas déjà dans le réseau, ce qui fait en sorte que plusieurs n'ont pas accès à des services dont ils auraient besoin

#39 • internet

accès à l'habitation, accès à des services de soutien

#41 • internet

la barrière de la langue

#42 • internet

L'accès aux services.

#43 • internet

L'Accès aux services

#48 • internet

les soins podologiques sont un besoin très présent auprès de la clientèle mais non couvert par les CIUSSS, peut de protocole en place pour la prise en charge des problématiques podologiques ni pour la prestation des services au sein des CIUSSS ou CHSLD ou autres instances publiques. Étant un service non couvert par la RAMQ, les usagers ont besoin des services mais l'accès est limité ou inexistant

#49 • internet

Droit au SAD et répit

#59 • internet

Souvent nos usagers se retrouvent en zone grise (sans statut migratoire clair) et n'ont pas accès à vos services. Il y a aussi souvent une barrière de langue.

#61 • internet

Je suis la directrice de l'organisme et j'ai une formation en droit et sincèrement moi-même je n'ai aucune idée de quels droits des usagers vous faites références. L'accès? Si ce sont les droit par rapport à l'accès je dirais que c'est la lourdeur des procédures.

#64 • internet

Difficulté d'accès dans les lieux ou refus d'accès pour les bénéficiaires de chien-guide ou de chien d'assistance

#67 • internet

des services dans leur langue maternelle (pas français)

#69 • internet

Le droit des autochtones à être servi en anglais si c'est leur choix

#80 • internet

difficulté à accéder à des rendez-vous surtout lorsqu'il s'agit de voir un spécialiste. Aussi, passer le triage.

#81 • internet

L'accès aux services...

#91 • internet

Même réponse que précédemment. Je rajouterai qu'il est parfois complexe pour un usager d'avoir un suivi par un travailleur social.

#94 • internet

-Certains usagers mentionnent avoir dû insister avant d'avoir accès aux services d'un CLSC.

-D'autres mentionnent que le nombre de rencontres n'est pas suffisant pour répondre à leur besoin.

-Plusieurs de nos usagers expriment leur besoin d'être reçus dans leur langue d'origine ou en anglais et n'ont pas de réseau personnel pouvant les accompagner à leur rendez-vous au CLSC. Lors du rendez-vous ils constatent qu'il n'auront pas accès à un interprète et par conséquent l'aide qu'ils nécessitent.

#112 • téléphone

Santé mentale, itinérance, manque de ressources et manque de responsabilisation du gouvernement dans les cas difficiles et en demande de réinsertion. Les problèmes de fond de toxicomanie et de santé mentale ne sont pas en compte par le CIUSS et sont retournés dans la rue. Manque d'un organisateur communautaire pour nous aider.

Refus, stigmatisation ou soins inadaptés (n=25)

#4 • internet

Manque de respect, patience, racisme, non présentation de tous les services disponibles

#12 • internet

Pas d'accès aux services, stigmatisation, manque d'adaptation

#17 • internet

Préjugés, refus de traitement, mégenrage, utilisation du "dead name"

#25 • internet

En tant qu'organisme œuvrant dans le domaine des chiens d'assistance pour personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, l'Académie Stella se trouve à l'intersection de plusieurs réalités où les droits des usagers sont régulièrement mis à l'épreuve. Les situations problématiques rencontrées sont nombreuses, récurrentes, et révèlent à la fois des lacunes dans la compréhension du rôle du chien d'assistance et des préjugés persistants envers les personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

La première catégorie de situations concerne les refus d'accès dans les lieux publics et les commerces. Malgré le fait que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdise la discrimination fondée sur le handicap, incluant le recours à un moyen pour pallier ce handicap comme un chien d'assistance, plusieurs usagers se voient refuser l'entrée dans des restaurants, des épiceries, des taxis, des transports collectifs, des hôtels ou même des établissements de santé. Lorsque le handicap est invisible, comme c'est souvent le cas en santé mentale, les refus sont plus fréquents, car les commerçants ou employés présumant que la personne n'a pas de raison légitime d'être accompagnée d'un chien. Les usagers doivent alors faire la preuve de leur condition, ce qui porte atteinte à leur dignité, à leur vie privée et à leur droit à la confidentialité de leur diagnostic.

La deuxième catégorie de situations concerne les difficultés d'accès aux services de santé et de services sociaux. Paradoxalement, les établissements mêmes du réseau public refusent parfois l'entrée du chien d'assistance, que ce soit dans les salles d'urgence, les cliniques externes, les unités d'hospitalisation, les CLSC ou les CHSLD lors de visites. Certains professionnels de la santé méconnaissent le cadre légal applicable ou invoquent des règles d'hygiène, des allergies ou des protocoles internes pour justifier le refus. Or, priver un usager de son chien d'assistance dans un moment de détresse, particulièrement en santé mentale, peut aggraver considérablement sa condition et compromettre son droit de recevoir des services adéquats, sécuritaires et respectueux de sa personne.

La troisième catégorie touche le logement. Plusieurs propriétaires refusent de louer à des personnes accompagnées d'un chien d'assistance, invoquant des clauses interdisant les animaux, alors que la jurisprudence québécoise et les tribunaux ont clairement établi qu'un chien d'assistance ne constitue pas un animal de compagnie au sens habituel et que son refus peut constituer de la discrimination. Les usagers doivent alors entreprendre des démarches longues et stressantes auprès du Tribunal administratif du logement ou de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ce qui exige des ressources émotionnelles et financières considérables, souvent hors de portée pour des personnes déjà fragilisées.

La quatrième catégorie concerne le milieu du travail et les études. Des employeurs et établissements d'enseignement, malgré leur obligation d'accommodement raisonnable, hésitent ou refusent d'accueillir un chien d'assistance. Les personnes se voient parfois forcées de divulguer des informations sensibles sur leur santé mentale pour justifier leur demande, ce qui les expose à de la stigmatisation et à des conséquences sur leur parcours professionnel ou scolaire.

La cinquième catégorie de situations problématiques est liée à la reconnaissance même du chien d'assistance en santé mentale. Contrairement aux chiens guides pour personnes aveugles, dont la reconnaissance légale et sociale est bien établie depuis longtemps, les chiens d'assistance pour handicap psychologique souffrent d'un déficit de reconnaissance. Au Québec, le cadre réglementaire demeure moins clair que pour d'autres types de chiens d'assistance, et plusieurs instances exigent des preuves, des certifications ou des accréditations qui ne sont pas uniformément définies. Cela crée une zone grise où les droits des usagers sont difficiles à faire respecter, car ils dépendent souvent de la bonne volonté de l'interlocuteur plutôt que d'une application claire de la loi.

La sixième catégorie est celle des préjugés envers la santé mentale elle-même. De nombreux usagers de l'Académie Stella rapportent avoir été traités avec suspicion, condescendance ou incrédulité lorsqu'ils mentionnent qu'ils sont accompagnés d'un chien pour des raisons de santé mentale. Des commentaires tels que « votre maladie ne paraît pas », « vous semblez bien aller pourtant », ou

encore « c'est pas un vrai chien d'assistance » minent la dignité des personnes et traduisent une méconnaissance profonde des réalités du trouble de stress post-traumatique, du trouble anxieux sévère, de la dépression majeure, du trouble panique avec agoraphobie, du trouble de la personnalité limite, des troubles dissociatifs ou du trouble du spectre de l'autisme, pour ne nommer que ces conditions.

La septième catégorie concerne le droit à l'information et au consentement éclairé. Plusieurs usagers rapportent que les professionnels de la santé ne connaissent pas l'existence ou l'utilité des chiens d'assistance en santé mentale, et ne les présentent jamais comme une option complémentaire aux traitements classiques. Le chien d'assistance demeure un outil marginalisé dans l'offre de services, alors qu'il constitue pour plusieurs personnes un soutien déterminant dans leur rétablissement, leur autonomie et leur qualité de vie. Cette absence d'information prive les usagers d'un choix réellement éclairé quant aux moyens qui pourraient les aider.

La huitième catégorie est celle des difficultés administratives et financières. Les chiens d'assistance pour handicap psychologique ne bénéficient pas du même niveau de soutien financier public que d'autres aides techniques. Les frais d'acquisition, de formation, d'entretien, de soins vétérinaires et d'équipement reposent largement sur les usagers ou sur les dons aux organismes comme le nôtre. Cette inégalité de traitement compromet le droit à l'accès équitable aux moyens permettant de pallier un handicap, droit pourtant reconnu par les principes d'équité en santé.

La neuvième catégorie touche les situations de crise et d'hospitalisation. Lorsqu'un usager vit une crise en santé mentale et doit être hospitalisé, la question de la prise en charge du chien d'assistance devient souvent problématique. Les établissements ne permettent généralement pas la présence du chien pendant l'hospitalisation, malgré le rôle thérapeutique que celui-ci pourrait jouer, et les proches ou les ressources communautaires doivent improviser une prise en charge temporaire. Cette séparation forcée peut aggraver la détresse de la personne et complique son rétablissement.

Enfin, une dixième catégorie concerne le manque de recours accessibles. Lorsqu'un usager voit ses droits bafoués, les démarches pour les faire respecter sont complexes, longues et émotionnellement exigeantes. Porter plainte à la Commission des droits de la personne, entreprendre un recours devant un tribunal, contester une décision administrative, tout cela demande de l'énergie que plusieurs personnes vivant avec un trouble de santé mentale n'ont tout simplement pas. Résultat, plusieurs situations discriminatoires ne sont jamais dénoncées, et les pratiques problématiques persistent.

Ces situations, loin d'être isolées, traduisent une double vulnérabilité pour les personnes que nous accompagnons : celle d'être en situation de handicap psychologique, souvent invisible et mal compris, et celle d'être tributaires d'un outil d'assistance, le chien, dont la reconnaissance demeure imparfaite. Les droits des usagers, bien qu'inscrits dans les lois et les chartes, se heurtent quotidiennement à l'ignorance, aux préjugés, aux rigidités administratives et aux limites du cadre réglementaire. L'Académie Stella, à travers son travail de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, tente de faire avancer la reconnaissance de ces droits, mais beaucoup reste à faire pour que les personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale puissent exercer pleinement leur citoyenneté, accompagnées de leur chien d'assistance, dans tous les lieux et toutes les situations de la vie quotidienne.

#28 • internet

1. le non-respect des droits que les usagers possèdent en regard du réseau de la santé

#34 • internet

Les droits ignorés ou bafoués durant l'accouchement. Malheureusement, en milieu hospitalier, sans accompagnante à la naissance, il arrive beaucoup trop souvent que les femmes aient des traumatismes qui auraient dûs être évités. Cela arrive même lors d'un accouchement "facile" cela devient presque systématique lors d'accouchement difficile.

Aussi, avec la DPJ, les nouveaux arrivants et les familles ayant une légère déficience.

Le père n'est pas pris en considération par les infirmèr.es les médecins

#50 • internet

Que l'OPQ ait promulgué que la population doivent surtout consulter des psychologues !

#66 • internet

La présence policière est excessive. Les gens sont maltraités et traités comme si c'était pour leur bien. Les personnes transgenres sont exposées à un danger extrême dans les centres de détention et face à la police : elles sont victimes de nombreuses violences sexuelles et de brutalités. Comment aider les gens alors que la société ne fait qu'aggraver le problème ?

#68 • internet

Des femmes en situation de vulnérabilité qui ont besoin de soins pour leurs enfants et/ou elles-mêmes et qui se retrouvent dans des dédales du CIUSSS de façon interminable et dans des prises en charge complètement déficientes.

#70 • internet

Difficultés des usagers de se sentir écouté par certains professionnels.

#77 • internet

manque de professionnalisme du personnel de santé, refus de donner un service sans justification, incompétence des professionnels de la santé.

#78 • internet

mauvais accueil en raison de profilage, barrières linguistiques, limites de services en raison de précarité de statuts migratoires

#85 • internet

Coupures de services à domicile injustifiées. Mépris du personnel de la santé quant à la situation complexe des personnes en situation de handicap.

#89 • internet

Absence de prise en charge médicale et psychosociale ;

Gaslighting ;

Absence ou coupures de services au niveau des services d'aide à domicile ;

Non respect des besoins biopsychosociaux ;

Manque de reconnaissance des limitations fonctionnelles et des handicaps ;

Manque de connaissances et de formations des professionnel · les de la santé ;

#96 • internet

Une mauvaise expérience avec un · e professionnel · le de la santé (minimiser ce qu'ils vivent, prendre la situation pas assez ou trop au sérieux, ne pas prendre le temps d'expliquer les étapes actuelle et à venir, ne pas les informer d'à qui les informations seront divulgués, avoir un cadre d'intervention avec un manque de flexibilité)

#99 • internet

manque de considération et de souplesse face aux enjeux que peuvent vivre les usagers.

#100 • internet

Les droits aux soins comme l'hormonothérapie. Techniquement, ce n'est pas illégale de prescrire des

hormones, mais aucun CIUSSS offre un service aussi simple.

Se faire mégenrer c'est le problème majeur et souvent expliquer que ça doit être le prénom légal, mais lorsque la personne se fait appeler ou offrir des soins ce n'est pas nécessaire de la mégenrer. Ça va nuire aux soins de la personne et elle ne va pas retourner en chercher si elle en a de besoin à nouveau.

Certains professionnels ne sont pas d'accord avec la transidentité et vont refuser d'offrir des services ou leur aide va s'approcher à la thérapie de conversion. Heureusement ce n'est plus tant fréquent.

Les plaintes ne servent presque à rien. Demande beaucoup pour peu de résultats.

#102 • internet

Reconnaissance des séquelles oncologiques par les professionnels de la santé

#104 • internet

Lorsque nos membres expliquent leurs besoins selon leur condition de lésée médullaire, ils ne sont pas écoutés ou pris au sérieux.

#110 • téléphone

le droit de vivre en famille (placement d'enfant pour cause de pauvreté)

#111 • téléphone

Le refus de service et d'aide

#116 • téléphone

Jugement de l'usager (toximanie, itinérance, santé mentale, immigration, difficulté de comprendre le système, pauvreté...)

#119 • téléphone

Stigmatisation, même une forme de peur des personnes en itinérance

#121 • téléphone

Nos situations sont surtout avec la DPJ

#126 • téléphone

Le manque de considération de leur propre expertise et ressentis (handicaps ou santé mentale)

Manque d'information/communication (n=18)

#5 • internet

Comme je dis c'est plutôt l'inverse, ils défendent leur droit même quand ils auraient besoin d'être davantage protégés. Ils devraient être informés sur les cas où ils doivent se laisser aider...

#8 • internet

- Les situations d'hébergement

- Non information ou désinformation sur les services disponibles

#11 • internet

Le manque de connaissances des usagers de leurs droits et leurs difficultés à faire valoir.

#20 • internet

Les gens sont envoyé en refuge sans valider ce qu'il désire, aucune information transférer a l'organisme, ne recoivent pas les soins adéquats.

#24 • internet

Les situations problématiques que nous rencontrons le plus fréquemment concernent les difficultés d'accès aux services (délais d'attente, difficulté à obtenir un rendez-vous ou à rejoindre les bons services), le manque d'information claire sur les démarches à suivre, ainsi que des enjeux liés à la continuité des services.

Nous accompagnons aussi des usagers qui rapportent se sentir jugés, peu écoutés ou stigmatisés en raison de leur situation de précarité résidentielle, de leur santé mentale, de leur consommation ou de leur situation socioéconomique.

Certaines personnes vivent également des difficultés administratives (ex. RAMQ, documentation, références) qui peuvent retarder l'accès aux soins et aux services auxquels elles ont droit.

#33 • internet

Difficulté à changer de médecin. Difficulté à avoir toutes l'information sur la médication psychiatrique. Difficulté à être accompagné dans réduction de la médication. Situation de masquage diagnostique lorsque les personnes ayant des enjeux de santé mentale se présentent pour des enjeux de santé physique.

#35 • internet

manque d'information et de prise en charge. Pas de pivot central.

#65 • internet

Les situations problématiques les plus fréquemment rencontrées concernent l'incomplétude des informations essentielles, le fait que certaines étapes soient sautées ou absentes dans les procédures, guides ou ressources disponibles. Avec le temps, ces situations peuvent devenir plus complexes et entraîner des difficultés supplémentaires pour les usagers dans la compréhension et l'accès aux services.

#82 • internet

Difficulté d'entrer en contact avec les personnes ressources du CLSC. Difficile d'obtenir de l'information pour mieux comprendre les services offerts.

Circuit de référence, d'orientation, de suivi et de liste d'attente parfois obscur pour nous à comprendre.

#88 • internet

L'absence d'information et de connaissances. L'absence de mécanisme ou d'interface de communication adaptés, par exemple de services d'interprètes LSQ en cas d'urgence permettant un meilleur accès à nos services de santé. L'absence de messages ciblés invitant à la participation de tous et toutes.

#90 • internet

Le droit à l'information. Ils reviennent avec des médicaments, ne savent pas à quoi ils servent. Difficulté à réduire les doses, etc.

#97 • internet

Lors des rencontre des tables de concertation des quartiers, le langage utilisée par les gens du CIUSSS est hermétique et compris par les autres organismes qui côtoient les usagers . Le citoyen qui représente les aînés, lors de ces rencontres y perd le fil.

#107 • téléphone

Droit à l'information, ils ne sont pas informés. Il faut tout réexpliquer, même au niveau du système de santé avec les changements internet des dernières années. Ce n'est pas enseigné et pas adapté pour des clientèles en difficulté. quand leur question ou besoins n'entrent pas dans une case, il n'y a pas de suivi ou de personne humaine pour les diriger

#115 • téléphone

Les difficultés de langue et le manque de connaissance des statuts d'immigration (ce qu'ils ont droit ou pas en santé et services sociaux)

#117 • téléphone

Le manque de référencement au bon endroit ou le manque d'accompagnement face à la situation globale du jeune usager. Le CIUSS ne prend pas vraiment en compte notre évaluation ou les efforts du jeune pour se reprendre en main car il ne coche pas toutes les cases

#123 • téléphone

L'accès information et le suivi lorsque l'aîné est seul sans soutien. Parfois, on demande que le suivi soit fait avec l'organisme et il n'y en a pas... Donc manque de communication

#127 • téléphone

Manque d'accessibilité aux information et suivi trop lent

#129 • téléphone

Le manque d'informations claires pour avoir accès aux services et aussi le réseau internet n'est pas accessible à tous pour les aînés, les nouveaux arrivants, ceux qui n'ont pas de technologie ou les compétences...

Délais et suivi insuffisants (n=17)**#27 • internet**

Listes d'attente trop longues pour des besoins non urgents, mais auxquels on doit répondre dans un délai beaucoup plus court.

#29 • internet

absence de médecin de famille,
pas de médecins ou de psychologues disponibles, trop de listes d'attente

#31 • internet

dossier perdu et l'utilisateur doit recommencer son processus.

#44 • internet

Le non accès aux services, les délais d'attente qui les mettent dans des situations impossibles. Par exemple, une personne attendue plus d'un an une évaluation pour avoir un transport adapté. Ce transport était essentiel pour aller à l'hôpital recevoir des traitements et une opération. Après 3 fois où l'opération a été remise, faute de transport adapté ou de moyen pour y aller en transport privé, cette personne a perdu son tour et les conséquences sur sa santé sont permanentes.

#53 • internet

Fermeture de dossier alors qu'il y a beaucoup de besoin non répondu

#54 • internet

À l'interne, notre organisme ne rencontre pas de situations problématiques majeures : la culture de respect des droits est bien ancrée et le climat du centre de jour est sain. Les seules tensions extérieures que nous observons concernent les délais du réseau public (ex. : accès à un travailleur social, accès à un psychiatre) qui affectent indirectement la condition de nos usagers.

#62 • internet

Nous observons principalement des difficultés liées aux délais d'accès aux services, au manque de continuité entre les différents intervenants du réseau, à la complexité des démarches administratives ainsi qu'au manque d'information claire pour les familles.

Certaines familles ont également de la difficulté à comprendre les services auxquels elles ont droit ou à faire valoir leurs besoins auprès des différentes instances.

#63 • internet

La liste d'attente pour certains services ou traitements est excessivement longue. Les requêtes de certains usagers sont rejetées. Des frais sont demandé à certains usagers pour remplir un formulaire p.ex transport adapté.

#84 • internet

le syndrome de la porte tournante. Ils ont besoin de plus de services mais on soigne et mets dehors sans travailler sur la ou les causes du pourquoi le patient c est retrouvé a l hôpital.

#95 • internet

Problème d'accès aux places protocoles CLSC-CPE. Les critères d'accès sont variables d'un CLSC à l'autre. De plus, l'attente d'une TS et ensuite l'attente d'une place protocole est de plus 24 mois ! Enjeux majeurs pour trouver qui au CLSC est en charge de l'enseignement du gavage en service de garde.

#105 • téléphone

La plainte recue le plus souvent c'est l'attente et la difficulté d'être aidé, surtout en santé mentale ou autre

#113 • téléphone

Le manque de relance du dossier pour ceux qui ont des difficultés

#114 • téléphone

La prise de position avec les enfants dans les situations problématiques et les retards et confusion face à la prise en charge, les délais sont trop longs

#118 • téléphone

Ne pas de suivi adéquat par rapport à leur demande

#122 • téléphone

La difficulté d'entrer dans le système, l'attente trop longue, alors que les hommes demandent en extrême urgence car ils n'ont pas tendance à demander pour se soigner

#124 • téléphone

Le manque de dossiers pris assez rapidement en charge, il faut des pressions du milieu pour faire accélérer. Il y a désabusement des usagers qui perdent confiance

#128 • téléphone

Les délais trop importants pour recevoir des services (sociaux et santé)

Aucun problème rencontré (n=11)

#3 • internet

Rien à signaler.

#6 • internet

nous ne rencontrons pas vraiment de problème

#10 • internet

Très peu puisqu'il y a une grande écoute et collaboration de la part de la direction. Facilement accessible et ouverte d'esprit.

#16 • internet

Nos membres ne nous en parlent pas vraiment

#18 • internet

je ne suis pas certaine.

#23 • internet

Aucun

#45 • internet

aucun

#55 • internet

N.A

#60 • internet

Sans objet

#71 • internet

Ne sais pas

#83 • internet

Aucune.

Confidentialité et consentement (n=8)

#14 • internet

La tension existante entre la responsabilité de protéger et la recherche d'autonomie et de liberté de choix.

#40 • internet

La confidentialité et le consentement, de ne pas leur avoir averti de leurs droits. Par exemple, droit d'avoir un interprète, un médecin femme ou homme, droit à un soin spirituel ou de leur religion.

#47 • internet

La demande de bailleurs de fonds sur des questions personnelles et qui n'a aucune raison en lien

avec l'aide.

Besoin alimentaire : adresse, sexe, âge, langue, etc. ??????

Go Toucan de Moisson Montréal en est un exemple!

#72 • internet

Les ordonnances de traitements, les gens sont peu écoutés quand ils sont non compliant. Aussi, ils apprennent leur diagnostics en lisant des extraits de dossiers de la cour. Ca frappe, pas d'explication

#76 • internet

Les membres de l'entourage veulent avoir davantage d'informations lors de la période d'hospitalisation, mais les règles de confidentialité empêchent à l'équipe traitante de donner des détails ou parfois même de faire de l'éducation psychologique sur les symptômes.

#92 • internet

Les personnes proches aidantes qui ne sont pas incluses dans les rencontres avec les équipes traitantes même lorsque les usagers donnent leur consentement. Informations trop opaques données aux usagers et à leurs proches, ce qui limite leur capacité à comprendre leur situation, les services et à donner un consentement éclairé.

#101 • internet

violations chartes

#125 • téléphone

Hospitalisations forcées avec la P38. Et une partie de la clientèle ne savent pas vraiment ce qu'ils prennent ou sont mêlés dans les suivis, donc une confusion dans le droit à l'information claire du dossier. dès qu'il y a un historique en santé mentale l'utilisateur n'est pas compris ou cru lorsqu'il a d'autres problématiques de santé physique.

non classable (n=7)

#0 • internet

Voir mission d'Action Autonomie

#1 • internet

Situation de vulnérabilité extrême provoque absence de mise de limites ou d'assurance par les personnes

#30 • internet

Voir les questions précédentes

#38 • internet

le service à l'hôpital

#79 • internet

logement insalubre

DPJ

Crises suicidaire

Aînés en perte d'autonomie

immigration

séparation

#87 • internet

#109 • téléphone

La rénoviction de logement (abusivement)
